

心脏骤停基层诊疗指南（2019年）

中华医学会 中华医学会杂志社 中华医学会全科医学分会 中华医学会《中华全科医师杂志》

编辑委员会 心血管系统疾病基层诊疗指南编写专家组

中华全科医师杂志, 2019,18(11): 1034-1041. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1671-7368.2019.11.006

一、概述

心脏骤停是猝死的主要原因^[1,2]。超过80%的心脏性猝死由导致心脏骤停的恶性心律失常如心动过速、心室颤动或心脏停搏引起，因此识别高危对象尤为重要。本指南在描述死亡方式时使用“猝死”这一术语，但涉及其直接原因、临床表现和治疗抢救时，使用“心脏骤停”这一术语，二者不应混淆。

减少心脏骤停的方法是做好高危患者的二级预防，已有冠状动脉粥样硬化性心脏病（冠心病）、心肌病、任何原因心力衰竭、高血压、糖尿病、高脂血症等疾病的患者应在医生指导下积极并规范服药治疗，保持健康生活方式。高危患者的二级预防可参考相关指南。需强调根据患者具体情况，在医生指导下做好预防。已有室性心律失常的患者应由专业医生进行危险评估，必要时予药物或手术（射频、起搏器等）治疗。

心脏骤停一旦发生，及时有效的心肺复苏（CPR）至关重要。2015年国际CPR指南指出，4 min内成功被救者，存活率可达32%。因此，若在院外或无除颤设备的地方发现有心脏骤停患者，应立即呼救，然后迅速开始徒手CPR；若在院内或有除颤设备的地方，应迅速获取除颤仪，检查心律情况，符合除颤指征者立即除颤，若同时有2人在场，可1人先行心肺复苏，等待另1人获取除颤仪，力争使患者在最短时间内得到最有效的救治措施。

（一）定义与分类

心脏骤停是指心脏突然停止射血，造成循环停止而产生的一系列症状和体征，包括意识丧失、晕厥、大动脉搏动消失等。心脏骤停是猝死的重要原因。心脏骤停根据其机制可分为4种情况：心室颤动、无脉搏室性心动过速、心脏静止和电机械分离。前2种被称为“可复律”心脏骤停。

（二）流行病学

美国2016年经急救系统估计的院外心脏骤停发生率为每年110.8例/10万人，或成人34.7万例/年^[2]；据美国研究报告，院外心脏猝死患者的中位年龄为65岁^[2]。根据国家“十五”公关项目“中国心脏性猝死流行病学调查”资料报告，2005—2006年，在我国4个代表性区域入选的近68万人群研究显示，中国心脏性猝死发生率为每年41.8例/10万人，若以13亿人口推算，我国猝死的总人数约为54.4万例/年^[3]，现阶段实际人数可能更多。心脏骤停具有不可预知性，70.0%~87.8%的猝死发生在院外，如家庭、公共场所。

二、病因与发病机制